실손의료보험 3종 비교 분석

한화손보 일반(5세대) · 한화손보 유병자 · DB손보 유병자 — 가입제안서 3건을 담보별 보험료와 보장 내용 기준으로 대조하고, 실손 세대 변천·정부 개편 일정과 60세 이후 의료비 통계를 함께 정리했습니다.

작성일 2026.09.09
설계일 2026.09.07
보험기간 개시 2026.09.07

피보험자	직업	보험나이 변경일	비교 대상	모집인
조OO (여, 58세)	보육교사 · 상해 1급	2027-03-01	실손 단독 3건	OOO 010-**** - ****

기본형 · 일반심사

한화손보
한화실손의료보험(갱신형)V 무배당
5세대 · 기본형+특약1+특약2

36,837 원/월

비교 기준 (100%)

유병자 · 간편고지

한화손보
한화간편실손의료보험(갱신형) 무배당2604
간편고지 실손 신규계약용

54,882 원/월

기본형 대비 **+18,045원 · 149%**

유병자 · 간편고지 3Q

DB손해보험
무배당 프로미라이프 간편실손의료비보험(유병력자용)2607

64,508 원/월

기본형 대비 **+27,671원 · 175%**

01 — 세대 변천과 정부 방침

실손보험은 다섯 번 바뀌었고, 앞으로도 바뀝니다

지금 비교하는 세 상품은 **5세대(2026년 5월 6일 출시)** 체계 위에 있습니다. 이 세대 구분이 어떻게 만들어졌고 앞으로 어떻게 바뀌는지를 먼저 보면, 뒤의 보험료·담보 비교가 훨씬 분명해집니다.

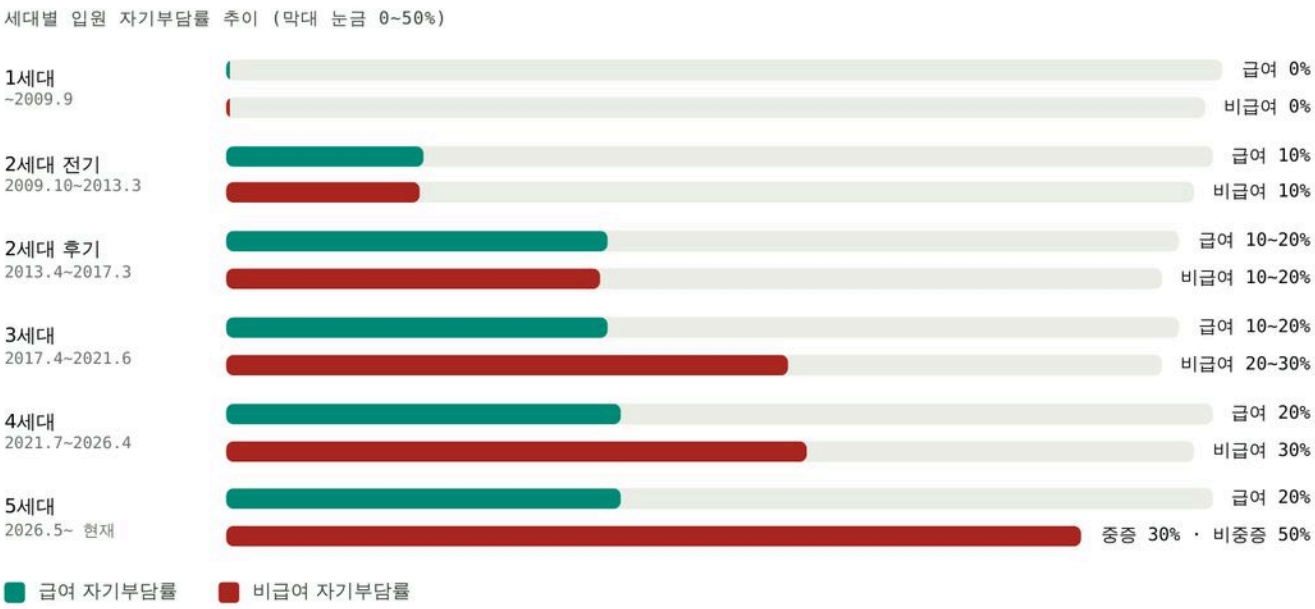
① 1세대부터 5세대까지 — 무엇이 어떻게 바뀌었나

세대	가입 시기	자기부담금	보장 한도	갱신 / 재가입	그 세대의 핵심 변화
1세대 구실손	~ 2009년 9월	입원 **없음 (100% 보장)** 통원 5천원 공제	입원 3천만~1억원 통원 10만~30만원	갱신 3~5년 재가입 없음	표준화 이전. 자기부담금이 없어 보장성은 가장 높으나 갱신 시 보험료 인상 폭이 큼
2세대 전기 표준화 도입	2009년 10월 ~ 2013년 3월	입원 **10%** 통원 1~2만원 공제	입원 5,000만원 통원 30만원	갱신 3년 재가입 없음	회사별로 제각각이던 보장을 하나로 통일하고 **자기부담금 개념을 처음 도입**. 가입 당시 조건이 만기까지 유지됨
2세대 후기	2013년 4월 ~ 2017년 3월	입원 10~20% 통원 1~2만원 공제	입원 5,000만원 통원 30만원	갱신 1년 재가입 15년	**재가입 제도가 처음 생긴 지점.** 15년 뒤에는 그때의 새 약관으로 다시 가입해야 함 — 약관 변경의 시작
3세대 착한 실손	2017년 4월 ~ 2021년 6월	급여 10~20% 비급여 20% **3대 비급여 특약 30%**	입원 5,000만원 통원 30만원	갱신 1년 재가입 15년	도수치료·비급여 주사·비급여 MRI를 **특약으로 분리**. 보험금 누수의 주범 세 가지를 본계약에서 떼어냄. 무사고 할인 도입
4세대	2021년 7월 ~ 2026년 4월	급여 20% 비급여 30%	급여·비급여 각각 입·통원 합산 연 5,000만원	갱신 1년 재가입 5년	**보험료 차등제** 도입 — 비급여를 많이 쓰면 다음 해 보험료 할증, 안 쓰면 할인. **재가입 주기가 15년에서 5년으로 단축**

세대	가입 시기	자기부담금	보장 한도	갱신 / 재가입	그 세대의 핵심 변화
5세대 현재 판매	**2026년 5월 6일 ~ 현재**	급여 입원 20% 급여 통원 건보 본인부담률 연동 중증 비급여 30% **비중증 비급여 50%**	급여 연 5,000만원 중증 비급여 연 5,000만원 **비중증 비급여 연 1,000만원**	갱신 1년 재가입 5년	**중증과 비중증을 분리.** 중증은 연간 자기부담 상한 500만원을 두어 방어력을 높이고, 비중증 비급여는 축소. 임신·출산과 발달장애 급여의료비를 새로 보장

5세대는 생명보험 7개사·손해보험 9개사 등 16개사가 판매합니다(신한EZ손보는 6월 1일 개시). 같은 세대라도 가입 시점의 세부 약관에 따라 조건이 다를 수 있습니다.

② 방향은 한쪽입니다 — 자기부담은 오르고 한도는 줄었습니다



17년 동안 급여 자기부담은 0%에서 20%로, 비급여는 0%에서 최대 50%로 올랐습니다. 같은 기간 비중증 비급여 연간 한도는 5,000만원에서 **1,000만원으로 줄었습니다. 세대가 내려갈수록 소비자 조건이 나빠지는 한 방향**이며, 되돌아간 적은 없습니다.

③ 정부는 왜 계속 바꾸나 — 손해율이 답입니다

세대	계약 건수	손해율	상태
1세대	1·2세대 합산 1,652만 5,721건	**102.3%**	받은 보험료보다 나간 보험금이 많음
2세대	〃	93.1%	유일하게 100% 미만
3세대	—	**120.3%**	**전 세대 중 최악** — 100원 받아 120원 지급
4세대	641만건 (17.7%)	**115.1%**	차등제 도입에도 손해율 개선 실패
전체	**3,622만건**	**—**	**가입자 약 4,000만명 (2024년 말)**

손해율 100%는 거둔 보험료를 보험금으로 전부 지급했다는 뜻으로, 사업비를 감안하면 100% 미만이어야 유지됩니다. 3·4세대가 120%대라는 것은 현행 요율로는 상품이 지속 불가능하다는 의미입니다.

실손보험료 연도별 평균 인상률	2022년	2023년	2024년	2025년
인상률	**14.2%**	**8.9%**	1.5%	**7.5%**

4년 누적으로 약 35% 올랐습니다. 손해율이 100%를 넘는 한 이 인상은 멈추지 않으며, 이것이 정부가 상품 구조 자체를 바꾸는 이유입니다.

> **정부가 든 또 하나의 근거 — 쏠림.** 실손 계약자의 **65%는 1년 동안 보험금을 한 번도 받지 않고**, 상위 **9%가 전체 보험금의 약 80%**를 가져갑니다. 실손이 부담하는 몫은 국민 총진료비의 10.6%(2023년)에 불과한데도 손해율이 120%대라는 것은, 일부의 과다 이용이 전체 가입자의 보험료를 밀어올리는 구조라는 뜻입니다. 5세대가 비중증 비급여를 축소한 배경이 여기에 있습니다.

④ 세대 교체는 언제, 어떻게 이루어지나 — 2026년 7월부터 10년

강제 전환 제도는 없습니다. 다만 계약을 두 갈래로 나눠 보면, 한쪽은 약관에 따라 **자동으로** 세대가 바뀌고 다른 한쪽은 정부가 **인센티브로** 유도합니다.

계약 유형	대상 · 규모	세대 교체 방식	강제성
㉮ 재가입 조항이 **있는** 계약	후기 2세대 · 3세대 · 4세대 **약 2,000만건**	재가입 주기(15년 또는 5년) 도래 시 **그 시점에 판매 중인 약관으로 자동 재가입**. 별도 건강심사 없이 넘어가지만 **보험료와 보장은 새 상품 기준**이 적용됨	사실상 자동 상품 원래 조건이므로 거부할 수 없음
㉯ 재가입 조항이 **없는** 계약	1세대 + 초기 2세대 **약 1,600만건**	약관이 만기까지 유지되어 자동 전환이 불가능. 정부는 **계약 재매입**(금융당국 권고 기준으로 보상 후 계약 해지, 이후 **무심사**로 신규 실손 가입 허용)과 **전환할인**으로 유도	선택 가입자가 받아들일지 결정

금융위원회 실손의료보험 개혁방안. ㉮ 유형 약 2,000만건은 **2026년 7월부터 2036년 6월까지 10년**에 걸쳐 **순차 전환**될 예정입니다.

세대 교체 일정

2021.07 — 4세대 출시
재가입 주기가 15년에서 5년으로 단축됩니다
이 한 줄이 오늘의 세대 교체를 만들었습니다. 4세대 가입자는 5년마다 그 시점의 상품으로 다시 가입하게 됩니다.

2025 하반기 — 정부 발표
실손의료보험 개혁방안 · 계약 재매입 시행방안
1·2세대 재매입 기준, 비급여 분쟁조정기준, 공시 강화가 순차적으로 마련됩니다.

2026.05.06 — 시행 완료
5세대 실손 출시 — 16개사 판매 개시
급여 / 중증 비급여 / 비중증 비급여 3층 구조. 보험료는 4세대 대비 약 30%, 1·2세대 대비 50% 이상 낮습니다. 조OO **님이 비교 중인 한화 일반형이 이 상품입니다.**

2026.07 — 진행 중
4세대 첫 재가입 만기 도래 — 세대 교체의 실질적 출발점
2021년 7월 가입자부터 5년 만기가 돌아옵니다. 연말까지 수십만 건, **향후 5년간 약 600만건**이 순차적으로 5세대 약관으로 넘어갑니다.

2026.11 — 시행 예정
1·2세대 전환 지원 제도
계약전환 할인 — 5세대로 갈아타면 3년간 보험료 50% 할인. **선택형 할인특약** — 계약은 유지하되 일부 비급여 보장을 빼고 보험료를 30~40% 낮춤. 첫 달 1·2세대 전환율이 0.03%에 그치자 정부가 추가로 내놓은 유인책입니다.

2029.09 — 조OO 님
유병자 실손을 고르면 여기서 첫 재가입
한화·DB 유병자 실손 모두 **보장내용 변경주기 3년**입니다. 만 61세 시점에 그때 판매 중인 유병력자 실손 약관으로 넘어갑니다.

2031.09 — 조OO
5세대 일반형을 고르면 여기서 첫 재가입
한화 5세대 일반형은 **보장내용 변경주기 5년**, 갱신 최대 4회입니다. 만 63세 시점에 그때 판매 중인 상품(6세대일 가능성)으로 재가입합니다.

2036.06 — 전환 완료 예정
재가입 조항이 있는 약 2,000만건의 세대 교체가 마무리됩니다
10년에 걸친 순차 전환의 종료 시점입니다. 이후 시장에 남는 구세대 계약은 재가입 조항이 없는 1세대·초기 2세대뿐입니다.

> **첫 달 성적이 정책의 방향을 말해줍니다.** 5세대 출시 첫 달 가입·전환은 50,289건(신규 43,031 · 전환 7,258)이었고, 그중 **1·2세대에서 넘어온 것은 5,534건, 전환율 0.03%**였습니다. 1·2세대 계약 1,652만건 중 사실상 아무도 움직이지 않은 것입니다. 보장이 좋은 구세대를 자발적으로 놓을 이유가 없기 때문이고, 그래서 정부는 **재매입 보상과 3년 50% 할인**이라는 카드를 더 꺼냈습니다. 반대로 말하면 **㉮ 유형(재가입 조항 있는 계약)의 전환은 설득이 필요 없습니다** — 약관대로 자동으로 진행되기 때문입니다.

⑤ 지금 가입하는 상품도 고정이 아닙니다

선택지	보장내용 변경주기	첫 재가입 시점	이후 재가입	최대 보장나이
한화 일반 (5세대)	5년	**2031년 9월 · 만 63세**	2036년(68세) · 2041년(73세) …	100세
한화 유병자	3년	**2029년 9월 · 만 61세**	2032년(64세) · 2035년(67세) …	110세
DB 유병자	3년	**2029년 9월 · 만 61세**	2032년(64세) · 2035년(67세) …	110세

재가입 시점에는 그때 판매 중인 약관·보험료가 적용됩니다. 건강심사는 다시 받지 않지만 조건은 새 상품 기준입니다.

이 표가 상담에서 가장 중요한 대목일 수 있습니다. "지금 조건이 평생 간다"는 이야기는 **1세대와 초기 2세대에만 해당**합니다. 조OO 님이 지금 고르는 세 상품은 모두 재가입 조항이 있어, 정해진 주기가 오면 그 시점의 약관으로 갈아타게 됩니다. 그리고 **유병자형은 변경주기가 3년이라 일반형(5년)보다 2년 먼저, 그리고 더 자주 약관 변경에 노출됩니다.** 지금까지의 흐름이 한 방향(자기부담 상승·한도 축소)이었다는 점을 감안하면, 변경주기가 짧다는 것은 그 흐름을 더 빨리 맞는다는 뜻입니다. 유병자형 선택 시 반드시 함께 설명해야 할 사항입니다.

02 — 일반형

한화 5세대 일반실손의 내용과 보험료

5세대 실손은 **급여 · 중증비급여 · 비중증비급여** 세 층으로 나뉜 단독상품입니다. 기본형(급여)은 필수이고, 특약1·특약2는 각각 따로 가입하거나 해지할 수 있습니다.

담보별 보험료 구성 — 8개 담보 / 월 36,837원

층	담보명	가입금액	보험료	구성비
기본계약 (보통약관) — 급여 실손의료비				
급여	실손의료비 (상해급여)	5,000만원 · 통원 회당 20만원	1,796	4.9%
급여	실손의료비 (질병급여)	5,000만원 · 통원 회당 20만원	19,725	53.5%
기본계약 소계 (2개)			**21,521**	**58.4%**
특별약관 1 — 중증 비급여 의료비				
중증비급여	실손의료비 (상해중증비급여)	5,000만원 · 통원 회당 20만원	40	0.1%
중증비급여	실손의료비 (질병중증비급여)	5,000만원 · 통원 회당 20만원	2,710	7.4%
중증비급여	실손의료비 (중증 3대비급여)	350만원 (근골격계 350 / 주사료 250 / MRI 300)	841	2.3%
특약1 소계 (3개)			**3,591**	**9.7%**
특별약관 2 — 비중증 비급여 의료비				
비중증비급여	실손의료비 (상해비중증비급여)	1,000만원 · 통원 일당 20만원	968	2.6%
비중증비급여	실손의료비 (질병비중증비급여)	1,000만원 · 통원 일당 20만원	7,537	20.5%
비중증비급여	실손의료비 (비중증비급여 자기공명영상진단)	200만원	3,220	8.7%
특약2 소계 (3개)			**11,725**	**31.8%**
합계 (8개 담보)			**36,837**	**100%**

보험기간 2026-09-07 ~ 2027-09-07 (1년만기 · 전기납 · 갱신) / 보장내용 변경주기 5년 / 최대 보장나이 100세

층별 보장한도와 자기부담률

구분	기본형 (급여)	특약1 (중증비급여)	특약2 (비중증비급여)
연간 보장한도 입·통원 합산	상해·질병 각 5,000만원	상해·질병 각 5,000만원	상해·질병 각 1,000만원
입원 자기부담	20%	30%	50%
입원 자기부담 연간 상한	200만원	500만원 (상급종합병원 한정. 근골격계 이학요법·체외충격파·주사료 제외)	—
통원 자기부담	Max [20%, 건보 본인부담률, 1만원(병·의원) / 2만원(상급·종합)]	Max [30%, 3만원]	Max [50%, 5만원]
통원 한도	회당 20만원 횟수 제한 없음	회당 20만원 · 연 100회	일당 20만원 · 연 100일
의료기관 종별 한도	—	없음	병·의원 입원 회당 300만원
상급병실료 차액	미보장	비급여 병실료의 50% (1일 평균 10만원 한도)	비급여 병실료의 50%
3대 비급여	—	근골격계 이학요법·체외충격파 350만원(50회) / 주사료 250만원(50회) / 비급여 MRI 300만원	비급여 MRI 200만원 (근골격계·주사료는 특약1에서만 보장)

통원은 외래 + 처방조제 합산 기준. 특약2는 비급여 이용량에 따른 보험료 차등제(할인·할증) 대상이나 본 설계에는 미적용으로 표기되어 있습니다.

보험료가 어디서 나오는지 — 질병급여 하나가 19,725원으로 전체의 53.5%입니다. 여기에 질병비중증비급여(7,537원)와 비중증 MRI(3,220원)를 더한 **세 담보가 30,482원, 전체의 82.7%**를 차지합니다. 반면 상해 관련 담보는 3개를 합쳐도 2,804원(7.6%)에 그칩니다. 보험료를 조정하려면 특약2(11,725원 · 31.8%)를 뺄지 여부가 유일하게 의미 있는 레버입니다.

03 — 유병자형 대 유병자형

DB손보 vs 한화손보 유병자 실손

두 상품 모두 **유병력자 실손** 표준을 따르므로 담보 구성은 상해·질병 × 입원·외래 **4개로 동일**합니다. 차이는 보험료와 계약 조건에서 발생합니다.

담보별 보험료 — 같은 구성, 다른 가격

담보	가입금액	한화 2604	DB 2607	차액	비중
상해입원의료비	5,000만원	4,705	4,514	-191	DB 유리
상해외래의료비	회당 20만원	711	879	+168	1.7%
질병입원의료비	5,000만원	28,883	37,676	+8,793	91.3%
질병외래의료비	회당 20만원	20,583	21,439	+856	8.9%
월 보험료 합계		**54,882**	**64,508**	**+9,626**	**117.5%**

차액 = DB − 한화. 비중은 총차액 9,626원에서 각 담보가 차지하는 몫. DB는 납입보험료 기준 64,450원(보장보험료 64,508원)이며 의료비수급권자인 경우 실손 특약 보험료의 5%를 추가 할인합니다.

차액의 91%는 질병입원 한 칸에서 나옵니다. 상해 담보는 사실상 동일하고 질병외래도 856원 차이입니다. 두 상품의 가격 차이는 **질병입원의료비 요율 하나**로 설명되며, 보장 내용의 차이 때문이 아닙니다. 같은 5,000만원 한도를 한화는 28,883원에, DB는 37,676원에 매기고 있습니다.

보장 조건 대조

항목	한화 간편실손 2604	DB 간편실손(유병력자용) 2607
월 보험료	**54,882원**	**64,508원** (납입 64,450원)
고지 방식	간편고지	간편고지 3Q · 자유설계
입원 자기부담	10만원과 보장대상의료비의 30% 중 **큰 금액** 공제 — 동일	
입원 자기부담 연간 상한	200만원 (초과분은 보상) — 동일	
외래 자기부담	2만원과 보장대상의료비의 30% 중 **큰 금액** 공제 — 동일	
외래 한도	회당 20만원 · 연 180회 — 동일	
상급병실료 차액	비급여 병실료의 50% 공제 후 보상 (1일 평균 10만원 한도) — 동일	
처방조제비	양사 모두 미보장	
3대 비급여 도수·체외충격파·증식치료 / 비급여 주사료 / 비급여 MRI·MRA	약관상 보상 제외 (유병력자 실손 공통)	제안서에 **보상 제외 명시**
보험기간 / 납기	1년만기 · 전기납	**3년만기 · 3년납**
갱신	1년 갱신 · 최대 2회	1년 갱신 · 최대 3년
보장내용 변경주기	3년 — 동일	
재가입 최대 나이	110세 — 동일	
국민건강보험 미적용 시	본인부담액의 40% 지급 — 동일	
부가 할인·제도	장애인 전용보험 전환특약 (소득세법 특별세액공제) / 출산·육아휴직 납입유예 / 해외체류 납입중지	의료비수급권자 실손 특약 보험료 **5% 할인**
만기환급금	없음 (순수보장성) — 동일	

표에서 회색으로 합쳐진 행은 두 상품이 실질적으로 동일한 항목입니다. 유병력자 실손은 표준화 상품이라 보장 구조 자체는 회사별로 거의 같고, 요율과 계약 형식에서 갈립니다.

04 — 3자 통합

기본형 대비 유병자형 두 상품

보험료

구분	한화 일반 (5세대)	한화 유병자	DB 유병자
월 보험료	36,837	54,882	64,508
기본형 대비 차액	기준	+18,045	+27,671
기본형 대비 배수	100%	149%	175%
담보 개수	8개	4개	4개
담보 1개당 평균 보험료	4,605	13,721	16,127

총 납입보험료 (제안서 예시 · 연령증가만 반영)

1년 누계	442,044	658,584	774,096
2년 누계	870,216	1,284,876	–
3년 누계	1,303,404	1,912,872 (만기)	2,320,764 (만기)
3년간 기본형 대비 추가 부담	기준	+609,468	+1,017,360

한화 일반은 5년만기 기준 총납입 2,192,856원까지 예시가 제공됩니다. 갱신 시 실제 보험요율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

보장 담보 — 무엇이 되고 무엇이 안 되는가

보장 항목	한화 일반 (5세대)	한화 유병자	DB 유병자
급여 입원	연 5,000만원 · 자기부담 20%	연 5,000만원 · 자기부담 30%	
급여 통원	회당 20만원 · **횟수 제한 없음** Max[20%, 건보본인부담률, 1·2만원]	회당 20만원 · 연 180회 Max[30%, 2만원]	
중증 비급여 입원	연 5,000만원 · 자기부담 30% 연간 자기부담 상한 500만원	급여와 합산 5,000만원 · 자기부담 30% 상한 200만원	
비중증 비급여 입원	연 1,000만원 · 자기부담 50% 병·의원 회당 300만원	급여와 합산 5,000만원 · 자기부담 30%	
도수·체외충격파·증식치료	연 350만원 · 50회	보상 제외	
비급여 주사료	연 250만원 · 50회	보상 제외	
비급여 MRI · MRA	중증 300만원 + 비중증 200만원	보상 제외	
처방조제비	보장 (통원 합산)	미보장	
상급병실료 차액	특약1·2에서 50% 기본형(급여)만으로는 미보장	50% 공제 후 보상 1일 평균 10만원 한도	
연간 최대 보장한도	**1억 1,000만원** 급여 5,000 + 중증 5,000 + 비중증 1,000	**5,000만원** 상해·질병 각각	
가입 심사	일반고지 (정밀심사)	간편고지	간편고지 3Q
보장내용 변경주기	5년	3년	
최대 보장나이	100세	110세	

유병자형 두 상품은 보장 내용이 동일하므로 열을 합쳐 표기했습니다.

갱신 보험료 시나리오

	연령 증가만 반영			연령 증가 + 인상률 25% 가정		
경과	한화 일반	한화 유병자	DB 유병자	한화 일반	한화 유병자	DB 유병자
가입 (58세)	36,837	54,882	64,508	36,837	54,882	64,508
2년차 (59세)	35,681	52,191	63,385	**44,602**	**65,239**	**79,231**
3년차 (60세)	36,099	52,333	65,504	**56,405**	**81,770**	**102,350**
4년차 (61세)	36,497	52,903	71,148	**71,283**	**103,327**	–
5년차 (62세)	37,624	–	–	**91,854**	–	–
6년차 (63세)	39,467	–	–	**120,444**	–	–
8년차 (65세)	**44,130**	**63,107**	**78,377**	DB는 23년차(80세) 88,949원까지 예시 제공		

각 사 가입제안서에 기재된 조OO 님 본인 기준 예시값입니다. 연령 증가만 반영한 열은 초기 몇 년간 보험료가 오히려 내려가지만, 실제로는 의료수가·손해율 변동이 더해집니다. 우측 25% 가정은 각 사 제안서가 제시한 최대 인상폭 시나리오입니다.

05 — 차이점

일반형과 유병자형은 무엇이 다른가

보험료와 보장 담보를 중심으로 열여섯 가지로 정리했습니다.

01 가입 심사의 문턱이 다르다 — 유병자형이 존재하는 유일한 이유

일반형은 일반고지로 정밀심사를 거칩니다. 유병자형은 간편고지(DB는 3Q, 세 가지 질문)로 심사 항목을 줄여, 치료 이력이 있어도 인수가 가능합니다. 일반형 인수가 가능하다면 유병자형을 선택할 이유는 없습니다.

02 보험료가 1.5~1.8배가 된다

같은 58세 여성 기준으로 월 36,837원 → 54,882원(한화) 또는 64,508원(DB)입니다. 3년간 누적하면 기본형 대비 각각 **60만 9천원**, **101만 7천원**을 더 냅니다.

한화 일반	한화 유병자	DB 유병자
36,837원 / 월	54,882원 · +49%	64,508원 · +75%

03 담보 개수가 8개에서 4개로 줄어든다

일반형은 기본계약 2개 + 특약 6개로 구성된 3층 구조입니다. 유병자형은 상해·질병 × 입원·외래 4개 담보의 단층입니다. 보험료는 오르는데 담보 수는 절반이 됩니다.

04 급여 자기부담률이 20%에서 30%로 오른다

일반형 기본계약의 급여 입원 자기부담은 20%입니다. 유병자형은 30%(또는 10만원 중 큰 금액)입니다. 급여 진료비 100만원이 나오면 본인부담이 20만원에서 30만원으로 늘어납니다.

05 비급여 자기부담률은 겉보기엔 유병자형이 유리하다

일반형은 중증 비급여 30%, 비중증 비급여 50%로 나뉘지만 유병자형은 일괄 30%입니다. 숫자만 보면 비중증 구간에서 유병자형이 20%p 유리합니다. 다만 다음 항목 때문에 이 이점은 대부분 상쇄됩니다.

06 통원 자기부담 계산 방식이 다르다

일반형 급여 통원은 **Max[20%, 건보 본인부담률, 1만원(병·의원)/2만원(상급·종합)]**, 유병자형은 **Max[30%, 2만원]**입니다. 병·의원 소액 진료에서는 일반형이 1만원만 공제하는 반면 유병자형은 2만원을 공제합니다.

07 3대 비급여가 통째로 빠진다

도수치료·체외충격파·증식치료, 비급여 주사료, 비급여 MRI·MRA — 유병자형은 세 가지 모두 **보상 제외**입니다. 일반형은 특약1·2에서 이를 보장합니다. 이것이 두 유형 사이의 가장 실질적인 보장 차이입니다.

근골격계 이학요법·체외충격파	비급여 주사료	비급여 MRI·MRA
일반 연 350만원·50회 → 유병자 0원	일반 연 250만원·50회 → 유병자 0원	일반 중증 300 + 비중증 200만원 → 유병자 0원

08 처방조제비를 보장하지 않는다

일반형의 통원은 외래 + 처방조제 합산입니다. 유병자형은 **외래만** 보장하며 처방조제비는 제외입니다. 만성질환으로 약을 계속 타는 경우 체감 차이가 큽니다.

09 도수치료를 자주 받는다면 유병자형은 사실상 무보장 구간이 생긴다

비급여 자기부담률이 30%로 낮아도(⑤), 그 30%가 적용될 항목 자체가 제외(⑦)되면 지급액은 0원입니다. 비중증 비급여 자기부담 50%를 감수하더라도 일반형이 보장 범위 면에서 우위입니다.

보장 한도

10 연간 최대 보장한도가 1억 1,000만원에서 5,000만원으로 줄어든다

일반형은 급여 5,000만 + 중증비급여 5,000만 + 비중증비급여 1,000만을 각각 별도 한도로 씁니다. 유병자형은 상해·질병 각 5,000만원 하나로 급여와 비급여를 모두 소진합니다.

11 입원 자기부담 연간 상한이 200만원 하나로 통일된다

일반형은 기본형 200만원에 더해 특약1에서 상급종합병원 입원 시 500만원 상한이 별도로 작동합니다. 유병자형은 200만원 상한 하나뿐입니다.

12 통원 횟수 제한이 생긴다

일반형 급여 통원은 회당 20만원 한도에 **횟수 제한이 없습니다**. 유병자형은 연 180회로 묶입니다. 다만 180회는 대부분의 이용 패턴에서 충분한 수준입니다.

일반 · 급여	일반 · 중증비급여	유병자
회당 20만원 · 횟수 무제한	회당 20만원 · 연 100회	회당 20만원 · 연 180회

13 의료기관 종별 한도가 사라진다

일반형 특약2에는 병·의원 입원 회당 300만원 한도가 붙습니다. 유병자형에는 종별 구분이 없어, 이 항목만 놓고 보면 유병자형이 단순합니다.

계약 조건

14 보장내용 변경주기가 5년에서 3년으로 짧아진다

재가입 시점마다 그때의 새 약관이 적용됩니다. 유병자형은 그 주기가 3년이라 약관이 더 자주 바뀝니다. 갱신 횟수도 일반형 최대 4회(5년)인 반면 한화 유병자는 2회(3년), DB는 3년만기 구조입니다.

한화 일반	한화 유병자	DB 유병자
1년만기 · 갱신 4회 · 변경주기 5년	1년만기 · 갱신 2회 · 변경주기 3년	3년만기 3년납 · 변경주기 3년

15 최대 보장나이는 유병자형이 오히려 길다

일반형 재가입 한도는 100세, 유병자형은 110세입니다. 유병자형이 일반형보다 나은 유일한 계약 조건 항목입니다.

16 보험료를 조절할 레버가 없어진다

일반형은 특약1·특약2를 각각 따로 해지할 수 있습니다. 특약2만 빼면 월 11,725원(31.8%)을 줄일 수 있습니다. 유병자형은 4개 담보가 모두 기본계약이라 부분 조정이 불가능합니다. 또한 일반형 특약2에 붙는 비급여 이용량 차등제(할인·할증)도 유병자형에는 없습니다.

06 — 왜 비싸도 필요한가

의료비는 60세 이후에 몰려서 나옵니다

유병자 실손이 일반형보다 1.5~1.8배 비싼 것은 사실입니다. 다만 그 보험료를 **무엇과 비교하느냐**가 판단을 가릅니다. 조OO 님은 만 58세, 의료비가 실제로 지출되는 구간의 **바로 앞**에 계십니다.

① 여성 생애의료비의 절반 이상이 65세 이후에 발생합니다

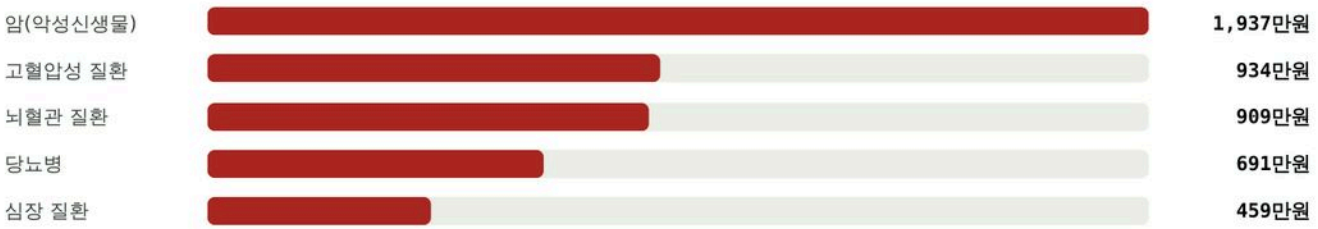
여성 1인 생애의료비 2억 2,307만원의 연령 분포 (2021년 현재가치)



65세 이전 · 약 **1억 507만원** 65세 이후 · 약 **1억 1,800만원**

유슬비(국민건강보험공단)·임달오(공주대) 「우리나라의 생애의료비 분포 추정」, 보건정보통계학회지. 남성은 생애의료비 1억 8,542만원 중 52.6%가 65세 이후. **65세까지 생존한 사람만**으로 좁히면 여성 생애의료비는 2억 5,047만원, 그중 **57.4%(약 1억 4,377만원)**가 65세 이후에 발생합니다.

주요 질환별 1인 생애의료비



같은 연구. 특히 **뇌혈관질환은 의료비의 80.4%가 65세 이후에 발생**합니다. 실손이 없으면 이 금액의 30~50%를 그대로 본인이 부담하게 됩니다.

② 65세 이후는 지출 밀도 자체가 다릅니다

1인당 연간 건강보험 진료비 (2024년)



국민건강보험공단 2024년 건강보험 주요통계. 65세 이상이 전체 평균의 **2.4배**를 씁니다.

전체에서 차지하는 몫 – 인구 대비 진료비 (2024년, 65세 이상)



65세 이상 진료비는 52조 1,935억원으로 전체 건강보험 진료비 116조 2,375억원의 44.9%입니다. 2020년 37조 6,135억원에서 **4년 만에 38.7% 늘었습니다**. 두 막대 모두 전체 100% 기준입니다.

③ 건강보험이 다 막아주지 않습니다 — 실손이 들어가는 자리

구분	보장률	본인부담률	의미
전체 평균	64.9%	35.1%	법정 본인부담 19.3% + 비급여 15.8%
65세 이상	69.8%	30.2%	연 550만원 기준 **약 166만원이 본인부담**
의료기관 종별 – 자주 가는 곳일수록 본인부담이 큽니다			
상급종합병원	72.2%	27.8%	큰 병원은 상대적으로 보장률이 높음
종합병원	66.7%	33.3%	
요양병원	67.3%	32.7%	전년 대비 1.5%p 하락
의원	57.5%	42.5%	동네 의원 진료비의 **42.5%가 본인 몫**
병원	51.1%	48.9%	중소 병원은 **거의 절반**이 본인 부담
질환별			

구분	보장률	본인부담률	의미
4대 중증질환	81.0%	19.0%	암·심장·뇌혈관·희귀난치
암질환	75.0%	25.0%	전년 대비 1.3%p 하락

국민건강보험공단 「2024년 건강보험 보장률」(2025.12.30 발표). 총진료비 138.6조원 = 보험자부담 90.0조 + 법정본인부담 26.8조 + 비급여 21.8조.

보장률 표를 뒤집어 읽으면 이렇게 됩니다. 65세 이상이 1년에 쓰는 진료비 550만원 중 **약 166만원은 건강보험이 내주지 않습니다**. 65세부터 20년을 잡으면 누적 3,300만원 수준이고, 이건 **평균**입니다. 암 진단 한 번, 뇌혈관 수술 한 번이면 이 평균은 의미가 없어집니다. 그리고 자주 가는 병원(51.1%)·의원(57.5%)일수록 보장률이 낮아, 큰 병이 아닌 일상 진료에서도 본인부담이 계속 쌓입니다.

④ 보험료를 어디에 견줄 것인가

유병자 실손 3년 총납입

191~232만원

한화 1,912,872원 · DB 2,320,764원
(3년 만기 기준)

65세 이후 20년 본인부담 추정

약 3,300만원

연 550만원 × 본인부담 30.2% × 20년
평균값이며 중증질환 발생 시 급증

65세 이후 발생할 총 의료비

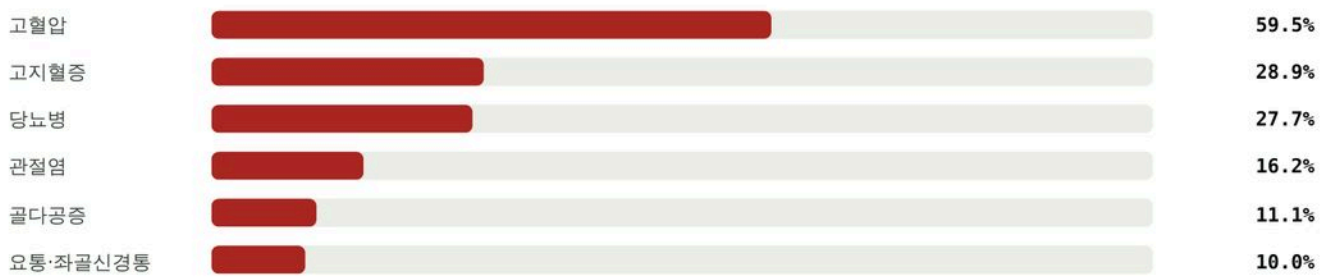
약 1억 1,800만원

여성 생애의료비 2억 2,307만원의 52.9%
65세 생존 기준으로는 1억 4,377만원

※ 본인부담 추정치는 건강보험 진료비 통계와 보장률을 곱한 개략값입니다. 건강보험 통계에 잡히지 않는 비급여 항목과 간병비·교통비 등 부대비용은 포함되어 있지 않아, 실제 지출은 이보다 큽니다.

⑤ 지금이 마지막 문일 수 있습니다

65세 이상 만성질병 유병률 (2023년 노인실태조사)



보건복지부 2023년 노인실태조사. **65세 이상의 86.1%가 만성질병을 1개 이상 보유**하고 있으며, 68.8%가 최근 1개월 내 의료기관을 이용했습니다(평균 1.5회). 막대는 모두 전체 노인 100% 기준입니다.

유병자 실손도 아무 때나 들어갈 수 있는 것은 아닙니다. 간편고지라도 **최근 2년 내 입원·수술·재검사 이력**과 **5년 내 암 진단 이력**은 걸러냅니다. 65세 이상의 86.1%가 만성질환을 갖게 되고 고혈압만 59.5%에 이르는 흐름을 감안하면, 시간이 갈수록 일반형은 물론 **유병자형조차 인수가 어려워집니다**. 만 58세인 지금은 두 선택지가 모두 열려 있는, 길지 않은 구간입니다.

유병자 실손은 왜 비싼가 — 금융위원회가 2018년 도입한 **유병력자 실손의료보험**은 「치료 이력이 있어 실손에 가입하지 못하는 국민의 보장 사각지대」를 없애기 위한 정책 상품입니다. 심사항목을 18개에서 6개로, 치료이력 심사기간을 5년에서 2년으로 줄이고, 중대질병 심사도 암 하나만 봅니다. 보험료가 높은 것은 **상품이 부실해서가 아니라 인수 문턱을 낮춘 만큼의 위험률이 요율에 반영된 결과**입니다. 도입 당시 금융위가 제시한 예시 보험료도 일반 실손 대비 약 68% 높은 수준이었고, 이번 설계(한화 +49% · DB +75%)도 그 범위 안에 있습니다.

07 — 판단 포인트

정리

"비싸다"의 기준은 월 보험료가 아니라 앞으로 나갈 의료비입니다

유병자 실손 3년 총납입은 191~232만원입니다. 같은 기간을 놓고 보면 큰돈이지만, 조OO 님이 65세 이후 부담하게 될 의료비는 여성 생애의료비 기준 **약 1억 1,800만원**이고 그중 건강보험이 내주지 않는 몫만 **20년 누적 3,300만원** 수준입니다. 보험료는 이 금액과 견주어야 판단이 섭니다. 만 58세는 그 구간이 시작되기 7년 전입니다.

일반형 인수가 가능한지가 첫 번째 갈림길입니다

한화 5세대 일반형은 보험료가 가장 낮으면서(36,837원) 보장 범위는 가장 넓습니다 — 3대 비급여와 처방조제를 포함하고 연간 한도도 1억 1,000만원입니다. 유병자형은 이 모든 면에서 열위이므로, 일반 심사 통과가 어려울 때 선택하는 대안입니다. 순서는 일반형 인수 가능 여부 확인이 먼저입니다.

유병자형이라면 두 상품의 보장은 사실상 같습니다

자기부담 구조, 한도, 처방조제 미보장, 3대 비급여 제외, 상급병실료 50%, 재가입 110세까지 모두 동일합니다. 유병력자 실손이 표준화 상품이기 때문입니다. 따라서 선택 기준은 보장이 아니라 **보험료와 계약 형식**이 됩니다.

같은 보장에 월 9,626원 차이가 납니다

한화 54,882원 vs DB 64,508원. 3년 누적으로는 407,892원 차이입니다. 이 차액의 91%는 질병입원의료비 요율(28,883 vs 37,676) 하나에서 발생하며, 보장 내용의 차이 때문이 아닙니다.

DB를 고를 이유가 있다면 계약 형식과 할인입니다

DB는 3년만기 3년납이라 1년만기인 한화보다 계약 관리가 단순하고, 조OO 님이 의료비수급권자라면 실손 특약 보험료의 5%를 할인받습니다. 반대로 한화는 장애인 전용보험 전환특약(소득세법 특별세액공제), 출산·육아휴직 납입유예, 해외체류 납입중지 같은 부가 제도가 붙습니다.

갱신 부담은 세 상품 모두 실손 공통 리스크입니다

25% 인상 가정 시 3년 뒤 보험료는 한화 일반 56,405원 · 한화 유병자 81,770원 · DB 유병자 102,350원입니다. 절대액이 큰 상품일수록 같은 인상률에도 체감 부담이 빠르게 커집니다. 유병자형을 선택한다면 이 곡선을 고객에게 미리 보여드리는 것이 좋습니다.

어느 쪽을 골라도 약관은 바뀝니다 — 다만 유병자형이 더 빨리 바뀝니다

세 상품 모두 재가입 조항이 있어, 정해진 주기가 오면 그 시점의 약관으로 넘어갑니다. 일반형은 5년(2031년·만 63세), **유병자형은 3년(2029년·만 61세)**입니다. 1세대부터 5세대까지의 변화가 줄곧 자기부담 상승·한도 축소 한 방향이었다는 점을 감안하면, 변경주기가 짧다는 것은 그 흐름을 더 자주 맞는다는 뜻입니다. 유병자형을 권할 때는 이 부분을 반드시 함께 말씀드려야 합니다.

결론적으로 미루는 것이 가장 비싼 선택입니다

보험료가 부담스러워 가입을 늦추면 두 가지가 동시에 나빠집니다. 첫째, 나이가 오르면서 요율이 올라갑니다(25% 가정 시 유병자 실손은 58세 54,882원 → 60세 81,770원). 둘째, 만성질환이 하나씩 붙으면서 인수 자체가 닫힙니다 — 65세 이상의 86.1%가 만성질환을 갖고, 고혈압만 59.5%입니다. **일반형이 되면 일반형으로, 안 되면 유병자형으로, 지금 결정하는 것**이 총비용 기준으로 가장 낮은 선택입니다.

> **자료 범위에 대하여** — 이번에 받은 자료는 한화 일반(5세대), 한화 유병자, DB 유병자 3건입니다. **DB손보 일반형(5세대) 가입제안서는 포함되어 있지 않아**, 「기본형」 기준은 한화 5세대로 잡았습니다. DB 일반형과의 직접 비교가 필요하시면 해당 설계서를 주시면 같은 형식으로 추가해 드리겠습니다.

출처 — 한화손해보험 「한화실손의료보험(갱신형)V 무배당」 가입제안서 LA260907866332-1 (2026.09.07 13:57 발행) / 한화손해보험 「한화간편실손의료보험(갱신형) 무배당2604」 가입제안서 LA260907871763-1 (2026.09.07 14:17 발행) / DB손해보험 「무배당 프로미라이프 간편실손의료비보험(유병력자용)2607」 가입제안서 설계번호 44367631-09-6-0002 (2026.09.07 17:09 발행)

제도·정책 출처 — 금융위원회 「실손의료보험 개혁방안」 및 5세대 실손 출시 보도자료 (계약 재매입, 재가입 주기, 2026.7~2036.6 순차 전환, 2026.11 전환 지원) / 파이낸셜투데이 「전환율 0.03% 그친 5세대 실손, 실손 개혁 2막 열린다」 (세대별 손해율·계약 건수·첫 달 전환 실적) / 투데이신문 「4세대 실손 첫 만기, 600만건 전환 예고」 / 실손보험 변천사 자료 (1~5세대 세대 구분)

통계 출처 — 유슬비(국민건강보험공단)·임달오(공주대학교) 「우리나라의 생애의료비 분포 추정」, 보건정보통계학회지 (생애의료비·65세 이후 비중·질환별 생애의료비) / 국민건강보험공단 「2024년 건강보험 주요통계」 (65세 이상 진료비 52조 1,935억원·44.9%, 1인당 550만원) / 국민건강보험공단 「2024년 건강보험 보장률」 2025.12.30 발표 (전체 64.9%, 65세 이상 69.8%, 종별·질환별 보장률) / 보건복지부 「2023년 노인실태조사」 (만성질병 유병률 86.1%, 질환별 유병률) / 금융위원회 유병력자 실손의료보험 도입 보도자료 (심사기준 완화 내용)

유의 — 본 자료는 각 사 가입제안서를 요약·대조한 참고용 문서입니다. 가입제안서 자체가 약관의 일부를 요약한 것이므로 실제 보장 여부와 지급 기준은 각 상품의 약관을 따릅니다. 인수지침·상품 운영기준이 반영되지 않아 회사 승인 후 보험계약사항이 최종 확정되며, 실제 가입 시 보장내용이 변경될 수 있습니다. 보험료는 매년 갱신 시 연령·의료수가·손해율에 따라 달라집니다.

작성 — (작성자 정보 가림)